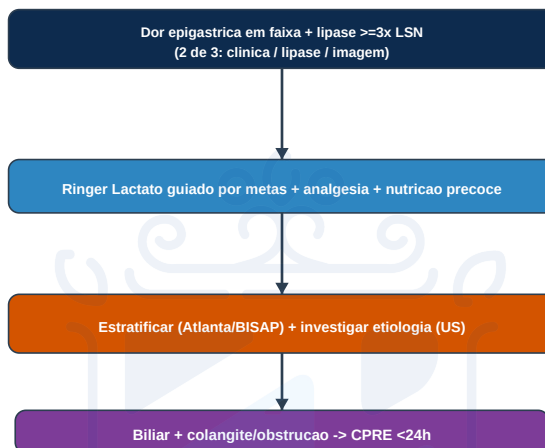


PANCREATITE AGUDA — ATLANTA + RINGER

FLUXOGRAMA — DIAGNÓSTICO E SUPORTE

PANCREATITE — 2 DE 3 + RESSUSCITAÇÃO GUIADA



DIAGNÓSTICO E ETIOLOGIA

2 DE 3 CRITÉRIOS

- Necessário ≥ 2 de 3: (1) dor abdominal típica (epigástrica, súbita, intensa, contínua, irradiação dorsal); (2) lipase $\geq 3\times$ LSN; (3) imagem compatível
- LIPASE é o marcador padrão-ouro (amilase é secundária); TC NÃO é obrigatória se clínica + lab claros
- Etiologia: BILIAR 40-50% (ALT > 150 forte preditor), ÁLCOOL 25-30%, HIPERTRIGLICERIDEMIA 5-10%, pós-CPRE, medicamentosa, idiopática
- Investigação nas primeiras 24h: US abdome (obrigatório), AST/ALT, triglicerídeos, cálcio, história medicamentosa/etílica
- Conceito 2025: é uma síndrome inflamatória SISTÊMICA com risco tempo-dependente

GRAVIDADE (ATLANTA) — DINÂMICA

Classe	Definição
Leve	Sem falência orgânica e sem complicações locais
Moderadamente grave	Falência orgânica TRANSITÓRIA ($< 48h$) e/ou complicações locais (coleções)
Grave	Falência orgânica PERSISTENTE ($> 48h$): resp ($PaO_2/FiO_2 < 300$), renal ($Cr \geq 1,9$), CV (vasopressor)
Risco (24h)	BISAP ≥ 3 , SIRS persistente, BUN em elevação, lactato alto, hipoxemia, idade > 60 , IMC > 30

MANEJO INICIAL — PRIMEIRAS 6h (TIME-CRITICAL)

Rx FLUIDO GUIADO + ANALGESIA + NUTRIÇÃO

FLUIDOTERAPIA: Ringer Lactato (preferencial), ressuscitação MODERADA e guiada por METAS — NÃO agressiva indiscriminada

Metas: PAM $\geq$ 65, FC $<$ 120, diurese $\geq$ 0,5 mL/kg/h, lactato em queda, hematócrito 35-44%

Excesso de fluido aumenta SDRA, edema pulmonar e síndrome compartimental abdominal

ANALGESIA: opioides EV (morfina, fentanil) + multimodal — opioides NÃO pioram desfechos

O₂ se SatO₂ $<$ 94%; avaliar risco de SDRA; gasometria se desconforto respiratório

NUTRIÇÃO ENTERAL PRECOCE ($<$ 24-48h): dieta oral se tolerada; SNG/nasojugal se intolerância; parenteral é último recurso

O QUE NÃO FAZER / PONTOS DE PROVA

ARMADILHAS

- ATB profilático NÃO é indicado; usar apenas se colangite, sepse comprovada ou NECROSE INFECTADA (PCR alta isolada $\neq$ ATB)
- TC com contraste NÃO de rotina $<$ 48h; melhor janela 72-96h (diagnóstico incerto, piora, suspeita de necrose)
- Jejum prolongado está PROSCRITO (nutrição precoce reduz infecção, falência orgânica e mortalidade)
- Necrose ESTÉRIL: conservador; INFECTADA: abordagem escalonada (ATB $\rightarrow$ drenagem $\rightarrow$ cirurgia), evitar cirurgia precoce
- Hipertrigliceridemia (TG $>$ 1000): insulina EV $\pm$ plasmaférese em casos selecionados

PANCREATITE BILIAR E SEGUIMENTO

CPRE E COLECISTECTOMIA

- CPRE URGENTE ($<$ 24h) se: colangite, obstrução biliar persistente, icterícia + colestase + dilatação de via biliar
- Colecistectomia: pancreatite biliar LEVE $\rightarrow$ na MESMA internação; grave $\rightarrow$ após estabilização
- Laboratórios seriados: BUN, creatinina, hematócrito, PCR (monitorização)
- Complicações locais: necrose estéril/infetada, coleções, pseudocisto; sistêmicas: SDRA, IRA, choque, coagulopatia, hiperglicemia
- Reavaliar a gravidade DIARIAMENTE nas primeiras 72h (é dinâmica)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com dor epigástrica em faixa; lipase ____ x LSN; etiologia provável: ____ (biliar/álcool/TG).
- Gravidade (Atlanta): ____; BISAP ____; SIRS ____; falência orgânica ____; lactato ____.
- Condutas: Ringer Lactato guiado por metas (diurese ____), analgesia opioide ____, nutrição ____; ATB só se ____.
- Solicito UTI se falência orgânica persistente; CPRE $<$ 24h se colangite/obstrução; transporte com monitorização.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Sobre a fluidoterapia atual na pancreatite aguda, é correto:

- A) Ressuscitação agressiva e indiscriminada com grandes volumes para todos
- B) Ringer Lactato em ressuscitação moderada e guiada por metas (PAM, diurese, lactato, hematócrito)
- C) Restrição hídrica desde a admissão
- D) Soro glicosado a 5% como primeira escolha
- E) Apenas hidratação oral em todos os casos

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o marcador laboratorial padrão-ouro para o diagnóstico de pancreatite aguda?

- A) Amilase
- B) Lipase $\geq 3x$ o limite superior da normalidade
- C) PCR
- D) Bilirrubina total
- E) Lactato

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre antibiótico na pancreatite aguda, é correto:

- A) Profilaxia para todos desde a admissão
- B) Não usar profilaxia; reservar para colangite, sepse comprovada ou necrose infectada
- C) Sempre que a PCR estiver elevada
- D) Apenas se a amilase estiver alta
- E) Carbapenêmico de rotina em todos

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a nutrição na pancreatite aguda (paradigma atual), é correto:

- A) Jejum absoluto prolongado até normalização das enzimas
- B) Nutrição enteral precoce ($< 24-48h$), com dieta oral se tolerada
- C) Nutrição parenteral total de primeira escolha
- D) Restrição proteica rigorosa
- E) Dieta apenas após a TC de controle

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Em qual situação a CPRE urgente ($< 24h$) está indicada na pancreatite biliar?

- A) Toda pancreatite biliar
- B) Pancreatite biliar com colangite ou obstrução biliar persistente
- C) Pancreatite leve sem icterícia
- D) Apenas quando a amilase normaliza
- E) Nunca está indicada

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A conduta atual usa Ringer Lactato em ressuscitação MODERADA e guiada por metas (PAM ≥ 65 , diurese $\geq 0,5$ mL/kg/h, lactato em queda, hematócrito 35-44%); o excesso de fluido aumenta SDRA e síndrome compartimental.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A lipase $\geq 3x$ o LSN é o marcador padrão-ouro; a amilase é secundária. O diagnóstico exige 2 de 3: clínica típica, lipase elevada ou imagem compatível.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Não se faz profilaxia antibiótica; o ATB é reservado a colangite, sepse comprovada ou necrose pancreática infectada. PCR elevada isolada não indica antibiótico.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O paradigma atual é a nutrição enteral precoce ($< 24-48h$), com dieta oral se tolerada — reduz infecção, falência orgânica e mortalidade. O jejum prolongado foi abandonado.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A CPRE urgente ($< 24h$) é indicada na pancreatite biliar com colangite associada ou obstrução biliar persistente (icterícia + colestase + via dilatada), não em toda pancreatite biliar.

SM24
Suporte ao Plantão Médico